Tema 21 — Trabajo en equipo e interdisciplinariedad en los Servicios Sociales. Estructura de los equipos de trabajo

1. El Trabajo en Equipo en los Servicios Sociales

La complejidad inherente a las realidades sociales contemporáneas —caracterizadas por la multicausalidad de las situaciones de exclusión, la cronicidad del desamparo, las disfunciones familiares y las transformaciones demográficas— hace inviable cualquier pretensión de abordaje individualizado, lineal o atomizado desde una perspectiva unidisciplinar. En el seno del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, el **trabajo en equipo** constituye no solo una opción metodológica preferente, sino un principio de organización estructural y un imperativo legal para garantizar una atención integral, continua y eficaz a la ciudadanía.

1.1. Concepto y Diferenciación: Del Grupo al Equipo de Trabajo

En la teoría organizacional y psicosocial, es preceptivo distinguir con precisión conceptual entre un **grupo de trabajo** y un **equipo de trabajo**:

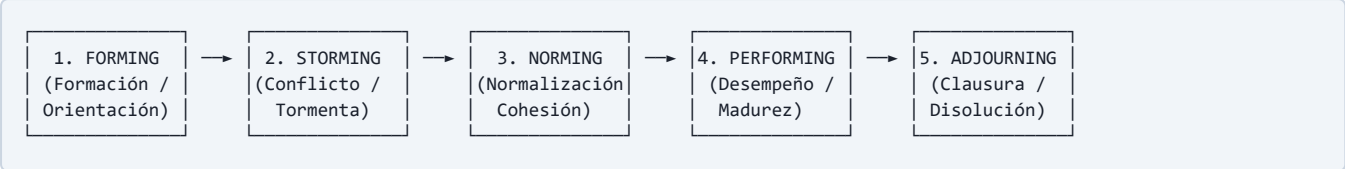
- **Grupo de trabajo**: Conjunto de personas que interactúan fundamentalmente para compartir información y tomar decisiones individuales orientadas a que cada miembro desempeñe su cometido dentro de su área de responsabilidad. El rendimiento grupal es una mera **suma algebraica de las contribuciones individuales**, no existe una responsabilidad mutua por el resultado final y las metas no están verdaderamente integradas.
- **Equipo de trabajo**: Dispositivo humano y técnico cohesionado, compuesto por profesionales con **habilidades complementarias**, comprometidos con un **propósito común**, con objetivos de rendimiento compartidos y con un enfoque metodológico respecto del cual se reconocen mutuamente **corresponsables**. La característica definitoria del equipo de trabajo es la generación de una **sinergia positiva**, donde el resultado global es cualitativa y cuantitativamente superior a la suma de los rendimientos individuales aislados.

Dimensión Analítica	Grupo de Trabajo	Equipo de Trabajo en Servicios Sociales
Liderazgo	Fuerte, individualizado y jerárquico	Compartido, rotativo o facilitador según la fase de la tarea
Responsabilidad	Individualizada y fragmentada	Colectiva, mutua y compartida sobre el caso social
Objetivos	Idénticos a la suma de metas individuales	Metas colectivas integradas en el Proyecto de Intervención Social
Productos de trabajo	Individualizados y aislados	Productos y planes de intervención colectivos y consensuados
Eficacia y rendimiento	Suma lineal de aportaciones	Sinergia positiva y abordaje biopsicosocial del caso
Toma de decisiones	Centralizada o por delegación	Deliberación colegiada y búsqueda técnica del consenso

1.2. Fases de Desarrollo y Evolución de los Equipos: El Modelo de Bruce Tuckman

La constitución de un equipo de trabajo técnico en el ámbito de los servicios sociales no es un fenómeno estático ni instantáneo, sino un proceso dinámico que atraviesa diversas etapas madurativas. El modelo teórico más

consolidado y preguntado en pruebas selectivas es el formulado por **Bruce W. Tuckman (1965, ampliado en 1977 con Mary Ann Jensen)**, que identifica cinco fases consecutivas:



1. **Fase de Formación (*Forming*)**:

- *Características*: Etapa inicial de orientación. Los integrantes experimentan incertidumbre respecto a la finalidad del equipo, la estructura jerárquica y el liderazgo. Predomina la cautela, la cortesía y la exploración de límites aceptables de comportamiento.
- *Papel de la coordinación*: Requiere un liderazgo directivo y estructurador que defina con claridad la misión institucional, los roles técnicos y los canales formales de comunicación.

1. **Fase de Conflicto o Tormenta (*Storming*)**:

- *Características*: Emerge la confrontación interpersonal y técnica. Los profesionales visibilizan discrepancias metodológicas, disputas sobre el reparto de la carga asistencial, solapamientos competenciales (por ejemplo, entre Trabajo Social y Educación Social) o resistencia al control directivo.
- *Superación*: Es una fase necesaria y saludable. Si se gestiona adecuadamente mediante el diálogo técnico y el respeto al marco competencial, el equipo sale fortalecido; si se evade o reprime, el equipo corre el riesgo de enquistarse en disfunciones crónicas.

1. **Fase de Normalización (*Norming*)**:

- *Características*: Se consolida la cohesión grupal y el sentido de identidad compartida (*sentimiento de "nosotros"*). Se establecen acuerdos tácitos y explícitos sobre las normas de funcionamiento interno, los protocolos de deliberación y la resolución pacífica de diferencias. Se acepta la complementariedad disciplinar.

1. **Fase de Desempeño o Rendimiento (*Performing*)**:

- *Características*: El equipo alcanza su plena madurez funcional y operativa. La estructura organizativa y las relaciones interpersonales se convierten en instrumentos de apoyo a la tarea común. Los profesionales actúan de manera autónoma, flexible y coordinada, centrando toda su energía en la resolución integral de las problemáticas sociales y familiares.

1. **Fase de Clausura o Disolución (*Adjourning*)**:

- *Incorporación de 1977*: Aplicable fundamentalmente a equipos temporales, comisiones de trabajo ad hoc o programas finalizados (como proyectos específicos de intervención comunitaria). Supone el cierre de tareas, la evaluación del impacto alcanzado y la gestión emocional de la separación del equipo.

1.3. Roles de Equipo según Meredith Belbin

En el funcionamiento interno de los equipos de servicios sociales, la eficacia técnica no depende exclusivamente de la formación académica o el puesto administrativo, sino del equilibrio entre las diferentes conductas y roles que desempeñan sus integrantes. **Meredith Belbin (1981)** definió el concepto de **rol de equipo** como una tendencia individual a comportarse, relacionarse y contribuir con los demás de una forma determinada.

Belbin clasifica los **nueve roles de equipo** en tres grandes categorías equilibradas:

A. Roles de Acción

1. **Impulsor (*Shaper*)**: Individuo dinámico, orientado al logro y con alta tolerancia a la presión. Desafía al equipo, fomenta el avance y supera obstáculos, si bien puede presentar la debilidad permitida de resultar

impaciente o herir susceptibilidades.

2. **Implementador (*Implementer*)**: Práctico, disciplinado, leal y eficiente. Transforma las ideas abstractas y los acuerdos de las reuniones en planes de acción y procedimientos operativos concretos.
3. **Finalizador (*Completer Finisher*)**: Meticuloso, esmerado y perfeccionista. Busca errores u omisiones en expedientes, plazos administrativos y memorias, asegurando el cumplimiento riguroso de los estándares de calidad.

B. Roles Sociales o de Relación

1. **Coordinador (*Coordinator*)**: Maduro, seguro de sí mismo y confiable. Clarifica metas, promueve la toma de decisiones consensuada y delega con eficacia, facilitando la participación equitativa de todas las disciplinas.
2. **Investigador de Recursos (*Resource Investigator*)**: Extrovertido, entusiasta y comunicativo. Desarrolla contactos externos, explora recursos en el entorno comunitario, negocia con otras instituciones (centros de salud, colegios, juzgados) y capta nuevas oportunidades.
3. **Cohesionador (*Teamworker*)**: Cooperador, perceptivo, diplomático y afable. Fomenta el clima positivo, escucha activamente, calma las tensiones interpersonales y evita enfrentamientos destructivos en las sesiones de equipo.

C. Roles Mentales o de Pensamiento

1. **Cerebro (*Plant*)**: Creativo, imaginativo y poco convencional. Genera propuestas innovadoras ante casos sociales crónicos o atascados, aportando enfoques no convencionales de intervención.
2. **Monitor Evaluador (*Monitor Evaluator*)**: Serio, prudente, perspicaz y analítico. Juzga con objetividad todas las opciones disponibles, evaluando la viabilidad técnica y los riesgos de cada alternativa de intervención antes de tomar decisiones irreversibles.
3. **Especialista (*Specialist*)**: Aporta conocimientos técnicos profundos, pericia especializada y rigor en áreas temáticas específicas (por ejemplo, legislación de menores, evaluación psicológica pericial o técnicas conductuales).

1.4. Dinámicas Relacionales, Comunicación y Toma de Decisiones

La calidad de las decisiones técnicas adoptadas en los Servicios Sociales Comunitarios está directamente condicionada por la salud del sistema comunicativo interno:

- **Comunicación asertiva y escucha activa**: Exige superar tanto la pasividad (silenciamiento técnico por temor a la jerarquía) como la agresividad (imposición autoritaria de un criterio disciplinar sobre otro). La asertividad permite defender el diagnóstico propio respetando las valoraciones ajenas.
- **Toma de decisiones colegiada**: En la intervención social, el modelo óptimo es la **decisión por consenso técnico**, donde todos los perfiles profesionales analizan el caso, exponen sus valoraciones y acuerdan un plan conjunto en el que se sienten representados. La votación por mayoría simple debe reservarse como mecanismo residual, pues suele generar fracturas internas y falta de compromiso en el sector disidente.
- **Conflictos funcionales vs. disfuncionales**:
- *Conflicto funcional o de tarea*: Discrepancia constructiva sobre la mejor estrategia socioeducativa o asistencial para un caso familiar. Fomenta el debate crítico, previene el pensamiento grupal (*groupthink*) y enriquece la toma de decisiones.
- *Conflicto disfuncional o relacional*: Enfrentamiento personal, luchas de poder territorial o descalificaciones mutuas entre profesionales. Paraliza la actividad técnica y deteriora la atención directa al usuario.

1.5. El Síndrome de Burnout y el Desgaste Profesional en Servicios Sociales

La intervención directa en servicios sociales expone de manera permanente al personal técnico a situaciones de dolor humano, maltrato, pobreza severa, violencia y exclusión, constituyendo una profesión de alto riesgo de

padecer el **Síndrome de Burnout** o síndrome de desgaste profesional crónico.

El modelo conceptual de referencia internacional es el desarrollado por **Christina Maslach y Susan Jackson (1981)** a través del cuestionario *Maslach Burnout Inventory* (MBI), que estructura el síndrome en tres dimensiones tridimensionales nucleares:

DIMENSIONES DEL SÍNDROME DE BURNOUT (MASLACH)		
1. AGOTAMIENTO EMOCIONAL	2. DESPERSONALIZACIÓN (CINISMO)	3. BAJA REALIZACIÓN PERSONAL
Sensación de no poder dar más de sí mismo a nivel afectivo. Pérdida total de energía vital.	Respuestas frías, distantes y cínicas hacia los usuarios. Cosificación del ciudadano como "expediente"	Sentimiento de ineficacia profesional, frustración de expectativas y pérdida de vocación pedagógica/soc

Medidas Preventivas y Cuidados del Equipo (*Cuidado del Cuidador*)

1. **Supervisión técnica de casos**: Espacio institucional reglado y periódico, conducido preferentemente por un profesional externo especializado, donde el equipo reflexiona sobre las dificultades metodológicas, los bloqueos emocionales y las transferencias/contratransferencias afectivas generadas por los casos más dolorosos.
2. **Clarificación y delimitación de roles**: Erradicación de la ambigüedad de rol y definición precisa de las competencias de cada perfil para evitar sobrecargas individuales.
3. **Distribución equitativa y rotación de casos de alta intensidad**: Evitar que los expedientes de mayor conflictividad o agresividad recaigan reiteradamente sobre el mismo profesional.
4. **Espacios formales de descompresión emocional**: Fomento de la cohesión interna y el apoyo mutuo interprofesional en la dinámica ordinaria del centro.

---

2. La Interdisciplinariedad en los Servicios Sociales

2.1. Clarificación Epistemológica: Gradación de los Modelos Disciplinares

En la literatura técnica y en las preguntas de examen tipo test, es esencial distinguir con exactitud epistemológica los cuatro niveles de articulación disciplinar:



1. **Monodisciplinariedad**:

- Abordaje del objeto de estudio o intervención desde una **única disciplina** científica o profesional, ignorando las demás perspectivas. Produce una visión reduccionista e incompleta de las necesidades sociales.

1. **Multidisciplinariedad**:

- Concurrencia de **múltiples disciplinas** sobre un mismo problema o usuario, pero **trabajando de manera yuxtapuesta, fragmentada y paralela**.
- Cada profesional realiza su propio diagnóstico con sus métodos particulares y aplica su tratamiento de forma autónoma, sin un marco teórico común ni deliberación cruzada. La coordinación es meramente informativa (suma de informes inconexos).

1. **Interdisciplinariedad**:

- **Nivel operativo normativo y metodológico propio del Sistema de Servicios Sociales**.
- Implica una **interacción recíproca, enriquecimiento mutuo y confrontación constructiva** entre disciplinas diferenciadas.
- Se construye un **marco conceptual, diagnóstico y evaluativo común**. Los profesionales no se limitan a sumar visiones, sino que elaboran una síntesis global de la situación familiar, asumiendo conjuntamente la responsabilidad del diseño, ejecución y evaluación del plan de intervención.

1. **Transdisciplinariedad**:

- Nivel epistemológico superior caracterizado por la **fusión o disolución de los límites disciplinarios tradicionales**. Se elabora una axiomática común y un lenguaje conceptual transversal que trasciende a las disciplinas de origen. En la práctica administrativa de los servicios sociales, es una meta teórica y formativa, pero no sustituye la diferenciación funcional de los puestos de trabajo.

2.2. Fundamentación Jurídica en Andalucía: La Ley 9/2016 de Servicios Sociales

La interdisciplinariedad no es una simple sugerencia de buenas prácticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino una **exigencia jurídica vinculante** consagrada de forma reiterada en la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía**:

A. Mandato Imperativo de Interdisciplinariedad (Artículo 30.1)

El **artículo 30.1** de la Ley 9/2016 prescribe con fuerza de ley:

> *"Cada centro de servicios sociales comunitarios estará dotado de un **equipo interdisciplinar de profesionales** que ostentarán la condición de empleados públicos, integrando personal técnico titulado y personal administrativo y de apoyo."*

Este mandato legal impone a todos los municipios andaluces la obligación de configurar sus plantillas de atención primaria bajo un modelo colegiado y no monoprofesional.

B. Habilitación Directiva Compartida (Artículo 30.2)

El **artículo 30.2** rompe con cualquier monopolio corporativo histórico sobre la dirección técnica de los centros de servicios sociales comunitarios:

> *"La dirección será ejercida por una persona empleada pública con **titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, educación social o psicología**."*

Este precepto sitúa a la **Educación Social en pie de igualdad jurídica** con el Trabajo Social y la Psicología para el ejercicio de la jefatura y dirección de los centros municipales.

C. Dotación Mínima Legal Obligatoria (Artículo 30.3)

El **artículo 30.3** fija la ratio legal imperativa que vincula a las administraciones locales:

> *"Los centros de servicios sociales comunitarios contarán, en todo caso, con una dotación mínima de profesionales que comprenderá al menos **un trabajador o trabajadora social, un educador o***

educadora social y un psicólogo o psicóloga."

D. Articulación mediante el Profesional de Referencia y el PIS (Artículo 31)

Para compatibilizar la interdisciplinariedad del equipo con la necesidad de garantizar a la persona usuaria una interlocución clara y no dispersa, el **artículo 31 de la Ley 9/2016** crea la figura del **Profesional de Referencia**:

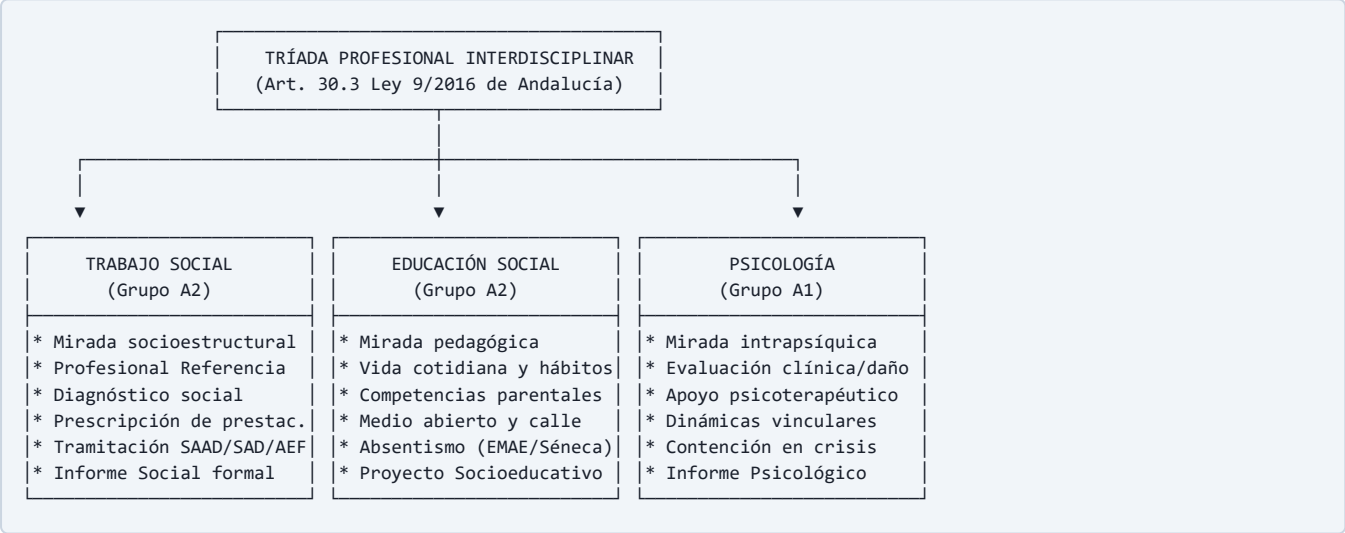
- Se reserva funcionalmente de forma obligatoria a una persona **Trabajadora Social**.
- Es quien realiza la valoración diagnóstica social inicial y ejerce la **prescripción facultativa de prestaciones** (artículo 31.2 y 34).
- Elabora y lidera, en coordinación con el equipo interdisciplinar, el **Proyecto de Intervención Social (PIS)**, canalizando internamente la derivación del caso hacia el/la Educador/a Social y el/la Psicólogo/a cuando las necesidades detectadas exijan su intervención especializada.

E. Soporte Unificado: La Historia Social Única (Artículo 55)

El **artículo 55 de la Ley 9/2016** establece la **Historia Social Única de Andalucía** como el expediente digital personal e intransferible que integra toda la información social, diagnósticos, valoraciones técnicas y prestaciones de la persona. Constituye el instrumento tecnológico vertebrador del trabajo interdisciplinar, permitiendo que las tres disciplinas compartan en tiempo real sus actuaciones y registros en la plataforma corporativa.

2.3. La Tríada Profesional Básica: Articulación de Miradas y Respeto Competencial

El núcleo operativo del equipo interdisciplinar en los Servicios Sociales Comunitarios descansa sobre tres pilares disciplinarios complementarios:



1. **Aportación del Trabajo Social (A2)**:

- Aporta la **perspectiva social, contextual e institucional**.
- Identifica factores de vulnerabilidad socioeconómica, red de apoyo familiar formal e informal y condiciones de habitabilidad.
- Asume el rol de Profesional de Referencia, emitiendo el Informe Social y garantizando el acceso a las prestaciones del Catálogo (SAD, dependencia, transferencias económicas, AEF).

1. **Aportación de la Educación Social (A2)**:

- Aporta la **perspectiva pedagógica, comunitaria y vivencial**.
- Interviene de forma directa en el entorno socioeducativo del sujeto (domicilio, escuela, calle, barrio).

- Modela habilidades para la vida diaria, entrena pautas de crianza y competencias parentales positivas, promueve la adquisición de hábitos de higiene, descanso y nutrición, y combate el absentismo escolar.
- Diseña e implementa el **Proyecto Socioeducativo Individualizado o Familiar**.

1. **Aportación de la Psicología (A1)**:

- Aporta la **perspectiva cognitiva, emocional y relacional**.
- Evalúa pautas de apego, desarrollo psicosexual, distorsiones cognitivas, desajustes comportamentales y sintomatología psicopatológica.
- Valora el daño emocional derivado de experiencias de maltrato o negligencia y ofrece contención emocional y psicoterapia breve individual o familiar.

---

3. Estructura y Organización de los Equipos de Trabajo en Servicios Sociales

3.1. Tipologías Estructurales en la Administración Pública Social

La organización formal de los recursos humanos en los Servicios Sociales de las Entidades Locales puede adoptar diversos modelos de diseño estructural:

1. **Estructura Funcional o Departamental**:

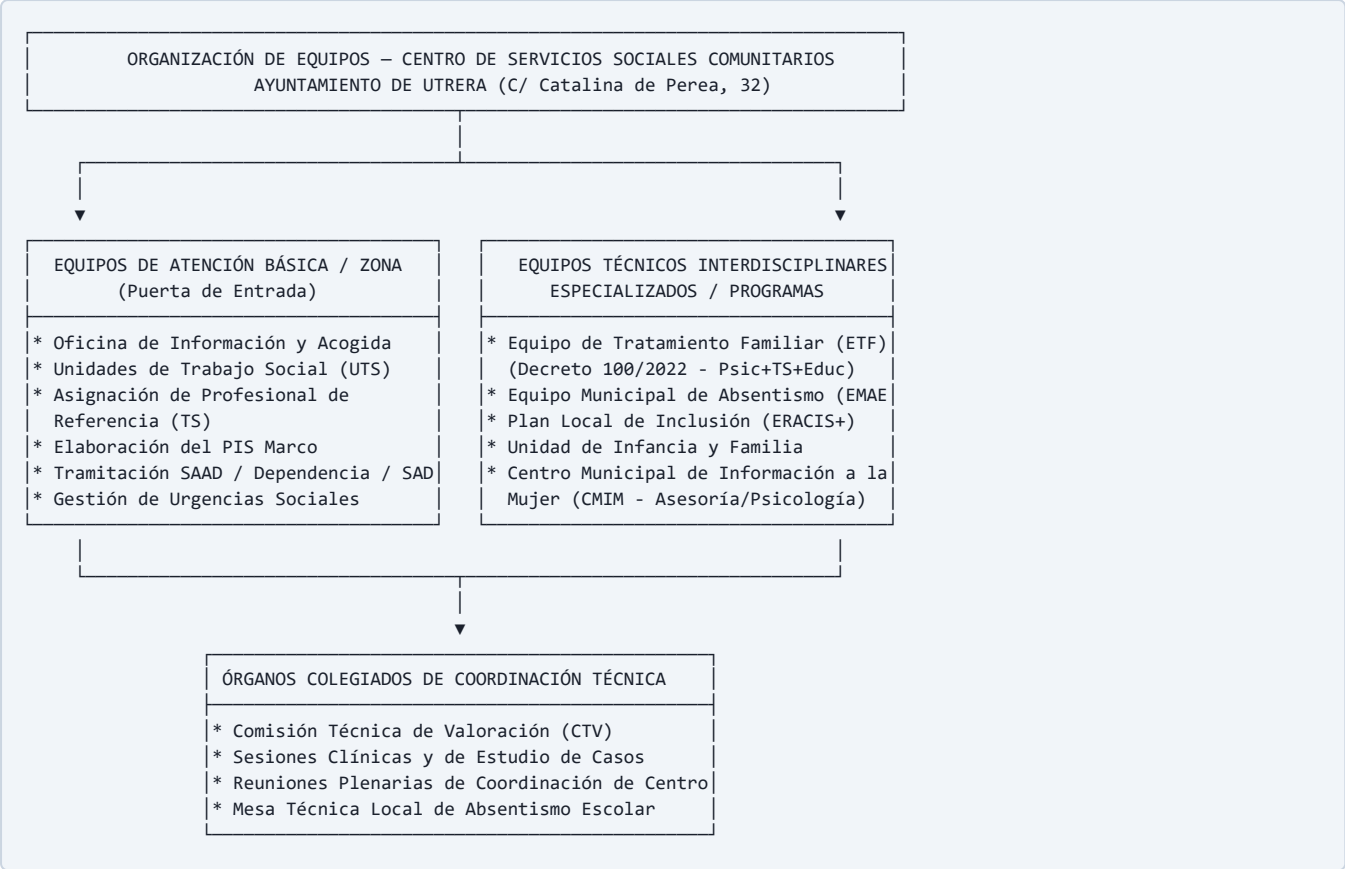
- Los profesionales se agrupan según su disciplina o función administrativa (departamento de trabajo social, departamento de psicología, negociado de administración).
- *Ventaja*: Alto rigor técnico y especialización gremial.
- *Inconveniente*: Genera "islas departamentales", fragmenta la atención al usuario, propicia la visión monodisciplinar y entorpece la coordinación integral.

1. **Estructura Matricial o por Proyectos/Programas**:

- Modelo predominante en los Servicios Sociales modernos. Los profesionales dependen jerárquicamente de la Dirección Técnica del centro, pero se asignan funcionalmente a equipos de trabajo transversales según programas específicos (Infancia y Familia, Absentismo Escolar, Dependencia, Inclusión en Zonas Desfavorecidas).
- *Ventaja*: Flexibilidad operativa, orientación al ciudadano y sinergia interdisciplinar efectiva.
- *Inconveniente*: Requiere madurez en la gestión para evitar conflictos de doble dependencia o indefinición de prioridades asistenciales.

3.2. Estructura Operativa en el Ayuntamiento de Utrera

En un municipio con una población superior a los 51.500 habitantes como el **Ayuntamiento de Utrera**, la estructura organizativa de los Servicios Sociales Comunitarios (con sede central en la **calle Catalina de Perea, 32**) se articula en torno a dos grandes subsistemas de equipos técnicos:



1. Equipos de Atención General y Equipos de Zona (UTS)

- Integrados fundamentalmente por Trabajadores/as Sociales de Zona y personal administrativo.
- Constituyen la puerta de entrada al sistema, gestionando la acogida, el triaje social, la valoración de emergencias, la prescripción de prestaciones económicas de urgencia social y el catálogo de dependencia (SAD y teleasistencia).

2. Equipos Interdisciplinares Especializados por Programas

- **Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)**: Configurado bajo el marco del **Decreto 100/2022, de 7 de junio** y el **Decreto 48/2025 (prestación garantizada 3.1.2)**. Integrado por 1 Psicólogo/a (A1), 1 Trabajador/a Social (A2) y 1 Educador/a Social (A2), destinado al tratamiento intensivo a domicilio para preservación y reunificación.
- **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Compuesto por Educadores/as Sociales en coordinación directa con la Policía Local (Agente Tutor) y la Inspección Educativa de Utrera.
- **Equipo del Plan Local de Zonas Desfavorecidas (ERACIS+)**: Equipo interdisciplinar de intervención comunitaria y sociolaboral en barriadas vulnerables del municipio.
- **Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)**: Dispositivo especializado que integra Asesoría Jurídica y Psicología para la atención integral a víctimas de violencia de género.

3.3. Órganos Colegiados de Coordinación y Espacios Técnicos

Para hacer operativa la interdisciplinariedad, el CSSC de Utrera cuenta con órganos y espacios colegiados formales:

1. **Comisión Técnica de Valoración (CTV)**:

- Órgano técnico colegiado de análisis multidisciplinar, integrado periódicamente por la Dirección del Centro, Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales y Psicólogos/as.

- *Funciones*: Baremos técnicos de situaciones de riesgo moderado y grave (**VALÓRAME**); dictámenes de idoneidad para la derivación al ETF o a recursos especializados; resolución de discrepancias en el diseño de los Proyectos de Intervención Social (PIS); y asignación de prestaciones de Ayudas Económicas Familiares (AEF).

1. **Sesiones de Estudio de Caso y Supervisión Técnica**:

- Espacio reflexivo semanal o quincenal donde los profesionales que comparten la intervención sobre una misma familia revisan los avances, evalúan el cumplimiento del contrato familiar y reformulan metas operativas.

1. **Reuniones Plenarias de Centro**:

- Encuentros de todo el personal técnico y administrativo para la transmisión de directrices corporativas, evaluación de memorias de gestión, análisis de cargas asistenciales y propuestas de mejora organizativa.

3.4. Instrumentos Técnicos y Tecnológicos de Soporte

El trabajo en equipo interdisciplinar requiere soportes instrumentales normalizados que impidan la arbitrariedad y la duplicidad burocrática:

- **Historia Social Única (HSU) y Aplicaciones de Gestión Social (NetCoas / SIUSS)**: Garantiza la custodia centralizada del expediente personal y el acceso autorizado de las distintas disciplinas a las anotaciones de campo y valoraciones técnicas.
- **Protocolos Normalizados de Intervención**: Circuitos protocolizados de derivación interna entre Trabajo Social, Educación Social y Psicología, con criterios claros de entrada, estancia y salida.
- **Instrumento VALÓRAME (Orden de 30 de julio de 2019)**: Escala técnica oficial que objetiva la gravedad del riesgo infantil a través de indicadores consensuados.
- **Sistema SIMIA (Decreto 210/2018, de 20 de noviembre)**: Plataforma telemática compartida para la notificación y seguimiento de casos de maltrato infantil.

---

4. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Fases del Modelo de Bruce Tuckman (1965/1977)**: 5 etapas en orden estricto: **Formación (*Forming*)**, **Conflicto/Tormenta (*Storming*)**, **Normalización (*Norming*)**, **Desempeño (*Performing*)** y **Clausura/Disolución (*Adjourning*)**.
2. **Año de incorporación de la fase *Adjourning* al modelo de Tuckman**: **1977** (junto con Mary Ann Jensen).
3. **Autor de los 9 roles de equipo**: **Meredith Belbin** (1981).
4. **Tres categorías de roles de Belbin**: Roles de **Acción** (Impulsor, Implementador, Finalizador); roles **Sociales** (Coordinador, Investigador de Recursos, Cohesionador); y roles **Mentales** (Cerebro, Monitor Evaluador, Especialista).
5. **Autoras de la escala de Burnout (MBI)**: **Christina Maslach y Susan Jackson** (1981).
6. **Tres dimensiones constitutivas del Burnout**: **Agotamiento emocional**, **Despersonalización (cinismo)** y **Baja realización personal en el trabajo**.
7. **Diferencia epistemológica entre multi e interdisciplinar**: En la *multidisciplinariedad* las disciplinas actúan de forma yuxtapuesta y paralela sin marco común; en la *interdisciplinariedad* existe interacción recíproca, marco conceptual compartido y síntesis diagnóstica común.
8. **Precepto legal de obligatoriedad del equipo interdisciplinar**: **Artículo 30.1 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía.

9. **Condición jurídica del personal de los equipos de servicios sociales comunitarios**: Obligatoriamente **empleados públicos** (art. 30.1 Ley 9/2016).
10. **Titulaciones habilitadas por ley para asumir la Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios**: Grado, licenciatura o diplomatura en **Trabajo Social, Educación Social o Psicología** (**Artículo 30.2 de la Ley 9/2016**).
11. **Ratio mínima legal obligatoria por Centro de Servicios Sociales Comunitarios (art. 30.3 Ley 9/2016)**: Al menos **1 Trabajador/a Social, 1 Educador/a Social y 1 Psicólogo/a**.
12. **Reserva funcional legal de la figura del Profesional de Referencia**: Exclusivamente reservada a una persona **Trabajadora Social** (**Artículo 31 de la Ley 9/2016**).
13. **Función de prescripción facultativa de prestaciones**: Competencia atribuida al Trabajador/a Social de referencia (**Artículos 31.2 y 34 de la Ley 9/2016**).
14. **Instrumento técnico vertebrador de la información interdisciplinar**: La **Historia Social Única de Andalucía** (**Artículo 55 de la Ley 9/2016**).
15. **Composición del Equipo de Tratamiento Familiar (art. 6 Decreto 100/2022)**: **1 Psicólogo/a (A1), 1 Trabajador/a Social (A2) y 1 Educador/a Social (A2)**.
16. **Calificación del Tratamiento Familiar en el Catálogo de Prestaciones**: **Prestación 3.1.2** del **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, como **PRESTACIÓN GARANTIZADA**.
17. **Instrumento oficial andaluz de valoración de gravedad del riesgo infantil**: **VALÓRAME** (aprobado por **Orden de 30 de julio de 2019**).
18. **Sistema oficial de información sobre maltrato infantil**: **SIMIA** (regulado por **Decreto 210/2018, de 20 de noviembre**).
19. **Órgano técnico colegiado de estudio y baremación en el CSSC**: **Comisión Técnica de Valoración (CTV)**.
20. **Técnica primordial de autocuidado del equipo frente al burnout**: La **supervisión técnica de casos** reglada y continuada.
21. **Tipo de conflicto deseable en un equipo maduro**: **Conflicto funcional o de tarea** (estimula el debate técnico y previene el pensamiento grupal).
22. **Tipo de toma de decisiones óptimo en intervención social**: **Decisión por consenso técnico** (frente a la imposición o la votación por mayoría simple).
23. **Sede del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera**: **Calle Catalina de Perea, número 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            MODELOS DE TRABAJO, ROLES Y MARCO LEGAL EN SERVICIOS SOCIALES
================================================================================

 1. NIVELES DE INTEGRACIÓN DISCIPLINAR
    ├── MONODISCIPLINAR  ──► 1 sola disciplina de forma aislada. Visión reduccionista.
    ├── MULTIDISCIPLINAR ──► Múltiples disciplinas yuxtapuestas en paralelo. Sin marco común.
    ├── INTERDISCIPLINAR ──► Interacción recíproca, marco común, corresponsabilidad. (Ley 9/2016).
    └── TRANSDISCIPLINAR ──► Disolución de límites disciplinares. Nuevo paradigma global.

 2. ETAPAS DE DESARROLLO DE EQUIPOS (TUCKMAN)
    [Forming: Formación] ──► [Storming: Tormenta] ──► [Norming: Normas] ──► [Performing: Éxito]
                                                                                    │
                                                    [Adjourning: Cierre] ◄──────────┘

 3. ROLES DE EQUIPO DE MEREDITH BELBIN (9 ROLES)
    ├── ROLES DE ACCIÓN   ──► Impulsor (Shaper) | Implementador | Finalizador
    ├── ROLES SOCIALES    ──► Coordinador | Investigador Recursos | Cohesionador (Teamworker)
    └── ROLES MENTALES    ──► Cerebro (Plant) | Monitor Evaluador | Especialista

 4. TRÍADA PROFESIONAL EN ANDALUCÍA (ART. 30.3 LEY 9/2016)
    ┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
    │ TRABAJO SOCIAL (A2)  │ EDUCACIÓN SOCIAL (A2)│   PSICOLOGÍA (A1)    │
    ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
    │* Profesional Ref.    │* Acción socioeducat. │* Diagnóstico clínico │
    │* Prescripción facult.│* Medio abierto/calle │* Daño emocional/apego│
    │* Diagnóstico social  │* Rutinas/parentalidad│* Terapia/contención  │
    │* HSU y PIS marco     │* P. Socioeducativo   │* Evaluación crisis   │
    └──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘
       ▲                                                              ▲
       └──────── PUEDEN ASUMIR LA DIRECCIÓN DEL CSSC (ART. 30.2) ─────┘

 5. DIMENSIONES DEL BURNOUT (MASLACH Y JACKSON)
    ├── 1. Agotamiento Emocional (Sensación de vacío y fatiga extrema)
    ├── 2. Despersonalización / Cinismo (Trato distante y cosificado al usuario)
    └── 3. Baja Realización Personal (Sentimiento de fracaso e ineficacia)
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre el concepto de interdisciplinariedad vs. multidisciplinariedad**:

- *Enunciado trampa*: *"Cuando un caso es valorado por un trabajador social, un psicólogo y un educador social que emiten tres informes independientes sin reunirse, estamos ante un modelo interdisciplinar."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Esa dinámica representa un modelo estrictamente **multidisciplinar** (yuxtaposición de disciplinas sin marco conceptual común). Para que exista **interdisciplinariedad** se exige interacción recíproca, diálogo técnico cruzado, corresponsabilidad y formulación de una síntesis diagnóstica y un plan integrados.

1. **Trampa sobre la titulación requerida para dirigir el Centro de Servicios Sociales Comunitarios**:

- *Enunciado trampa*: *"La dirección de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía queda legalmente reservada a funcionarios pertenecientes al cuerpo de Trabajadores Sociales."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 30.2 de la Ley 9/2016** establece expresamente que la dirección será ejercida por un empleado público con titulación de grado, licenciatura o diplomatura en **Trabajo Social, Educación Social o Psicología**. Las tres profesiones tienen idéntica habilitación legal para dirigir el centro.

1. **Trampa sobre el Profesional de Referencia**:

- *Enunciado trampa*: *"Cualquier miembro del equipo interdisciplinar (Trabajador Social, Educador Social o Psicólogo) puede ser designado como Profesional de Referencia del caso."*

- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 31 de la Ley 9/2016** establece de manera taxativa que la condición de Profesional de Referencia está atribuida exclusivamente a una persona **Trabajadora Social**, quien ostenta además la competencia privativa de la **prescripción facultativa de prestaciones**.

1. **Trampa sobre las fases de desarrollo del equipo de Tuckman**:

- *Enunciado trampa*: *"El modelo original de Bruce Tuckman formulado en 1965 contenía cinco etapas: Formación, Tormenta, Normalización, Desempeño y Clausura."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El modelo original de Tuckman de **1965 contenía únicamente cuatro etapas** (*Forming, Storming, Norming, Performing*). La quinta etapa, **Clausura o Disolución (*Adjourning*)**, fue añadida posteriormente en **1977** en coautoría con Mary Ann Jensen.

1. **Trampa sobre la composición mínima legal obligatoria**:

- *Enunciado trampa*: *"La ratio legal mínima por centro de servicios sociales comunitarios en Andalucía comprende 1 Trabajador/a Social, 1 Psicólogo/a y 1 Administrativo/a."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 30.3 de la Ley 9/2016** prescribe taxativamente que la dotación técnica mínima estará compuesta al menos por **1 Trabajador/a Social, 1 Educador/a Social y 1 Psicólogo/a**. La presencia del Educador/a Social es obligatoria por imperativo legal.

1. **Trampa sobre las dimensiones del Burnout según Maslach**:

- *Enunciado trampa*: *"Las tres dimensiones del síndrome de Burnout según Christina Maslach son: sobrecarga laboral, aislamiento social y depresión mayor."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Las tres dimensiones psicométricas del MBI (*Maslach Burnout Inventory*) son: **Agotamiento emocional**, **Despersonalización (o cinismo)** y **Baja realización personal en el trabajo**.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Utrera** (calle Catalina de Perea, 32), se convoca una **Comisión Técnica de Valoración (CTV)** con carácter de urgencia técnica para abordar el caso de la familia "R.M.", residente en la barriada de las VPO de Utrera, derivada por el Trabajador Social de Zona (Profesional de Referencia).

Composición de la Comisión Técnica de Valoración reunida:

- **Directora Técnica del CSSC** (Educadora Social, habilitada por el art. 30.2 de la Ley 9/2016).
- **Trabajadora Social de Zona** (Profesional de Referencia de la familia).
- **Técnico/a Medio de Educación Social** (del Equipo de Intervención Socioeducativa e Infancia de Utrera).
- **Psicólogo/a** (del Equipo de Tratamiento Familiar).

Datos del caso expuestos por la Trabajadora Social de Referencia:

- Unidad familiar compuesta por madre (34 años) e hijo (Carlos, 13 años).
- Pobreza severa sobrevenida por desempleo prolongado, riesgo de corte de suministros de agua y luz en el inmueble, y desestructuración relacional grave.
- Absentismo escolar cronificado de Carlos en el IES Ruiz Gijón de Utrera (más del 60% de inasistencias en el segundo trimestre).
- Sospecha de consumo incipiente de sustancias tóxicas en espacios públicos del municipio y conductas agresivas verbales continuadas hacia la madre.

- La escala **VALÓRAME** arroja una puntuación preliminar de **Riesgo Grave** con afectación en áreas relacional, escolar y conductual.

Despliegue del Trabajo Interdisciplinar en la Sesión Técnica:

1. **Deliberación Cruzada y Síntesis Diagnóstica Compartida**:

- *Trabajadora Social*: Informa de la precaria cobertura económica y habitacional. Dictamina la procedencia de tramitar con carácter de urgencia una **Ayuda Económica Familiar (AEF)** para suministros y alimentos, asumiendo la prescripción facultativa.
- *Psicólogo/a*: Analiza la dinámica relacional materno-filial, detectando un cuadro de desbordamiento emocional y sintomatología ansioso-depresiva reactiva en la madre, con un estilo de apego desorganizado en el menor. Propone citación individualizada para contención psicoterapéutica materna.
- *Educador/a Social*: Presenta el informe de coordinación escolar recabado de la Jefatura de Estudios y del Departamento de Orientación del IES Ruiz Gijón de Utrera. Propone una intervención educativa directa en medio abierto para trabajar rutinas horarias, habilidades sociales, ocio constructivo y seguimiento a pie de calle.

1. **Diseño Consensuado del Proyecto de Intervención Social (PIS)**:

- La CTV acuerda unánimemente que el caso no debe derivarse de inmediato a la Junta de Andalucía para desamparo, existiendo pronóstico favorable si se actúa de forma intensiva interdisciplinar en Utrera.
- Se aprueba un **PIS Integrado** con reparto claro de cometidos técnicos coordinados por la Trabajadora Social de Referencia:
- *Área Social (Trabajadora Social)*: Gestión inmediata de AEF de emergencia social e inserción de la madre en el programa de orientación sociolaboral de la Estrategia ERACIS+.
- *Área Psicológica (Psicólogo/a)*: Sesiones quincenales de terapia de apoyo y entrenamiento en control emocional materno en las dependencias de calle Catalina de Perea.
- *Área Socioeducativa (Educador/a Social)*: Dos intervenciones semanales domiciliarias y en medio abierto para modelar límites parentales, acompañar al menor al centro educativo en coordinación con el Agente Tutor de la Policía Local de Utrera e inscribirlo en la Escuela Municipal de Deporte (complejo deportivo de Vistalegre).

1. **Prevención del Desgaste y Evaluación de Equipo**:

- Para evitar el agotamiento emocional derivado de la agresividad verbal del adolescente, el equipo acuerda que las visitas a domicilio complejas se realicen de forma conjunta por el Educador Social y la Trabajadora Social, estableciendo una reunión técnica de seguimiento cada 3 semanas en el CSSC para monitorizar avances y garantizar el cuidado mutuo del equipo profesional.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Especializada

1. **Normativa Autonómica y Estatal**:

- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*). Artículos 27, 29, 30, 31, 34, 38 y 55.
- **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA extraordinario de 2025*).
- **Decreto 100/2022, de 7 de junio**, por el que se regula el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección (*BOJA nº 110, de 10 de junio de 2022*).
- **Ley 4/2021, de 27 de julio**, de Infancia y Adolescencia de Andalucía (*BOJA nº 149, de 4 de agosto de 2021*).

- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**), artículos 25 y 26.
- **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (**TREBEP**).

1. **Bibliografía Científica de Referencia en Dinámica de Equipos**:

- **Belbin, R. Meredith** (1981). *Management Teams: Why they succeed or fail*. Heinemann.
- **Maslach, Christina & Jackson, Susan E.** (1981). *The measurement of experienced burnout*. Journal of Occupational Behavior, 2(2), 99-113.
- **Tuckman, Bruce W.** (1965). *Developmental sequence in small groups*. Psychological Bulletin, 63(6), 384-399.
- **Tuckman, Bruce W. & Jensen, Mary Ann C.** (1977). *Stages of small-group development revisited*. Group & Organization Studies, 2(4), 419-427.